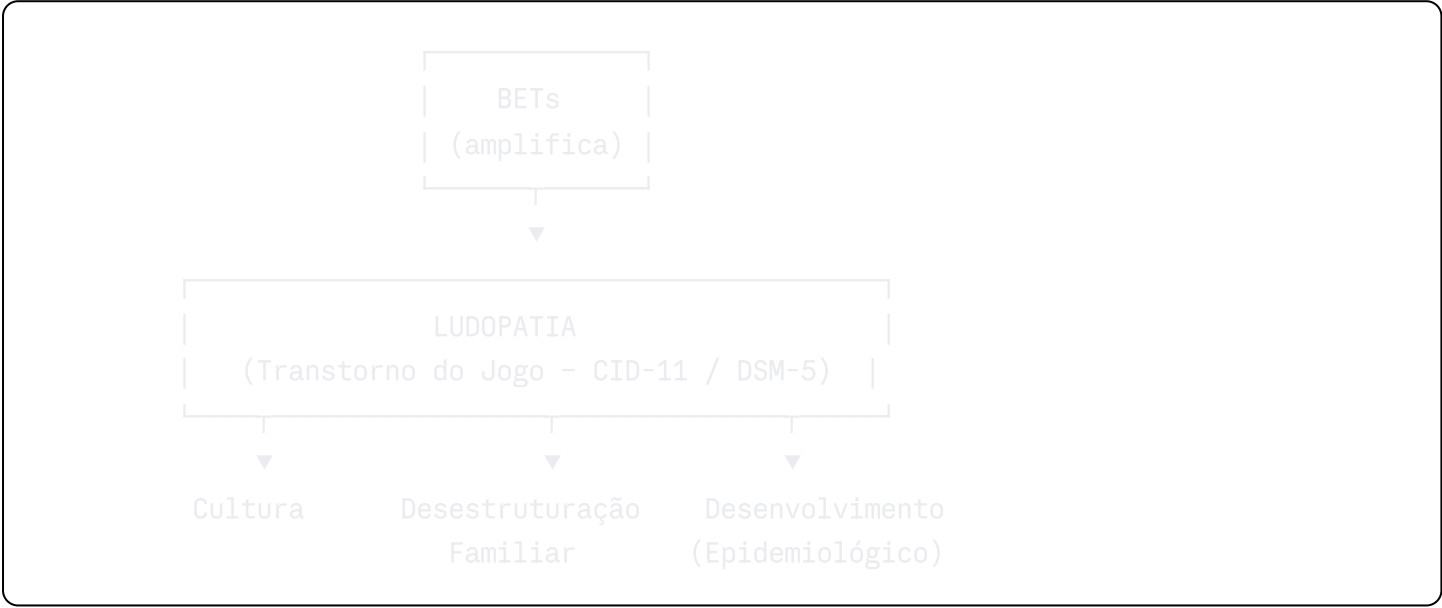


Pesquisa Científica - Ludopatia e BETs

Mapeamento Completo dos Conectores Temáticos

Projeto: Ludopatia e o impacto das BETs no Brasil **Eixo central:** Ludopatia como transtorno e seus conectores sociais, culturais e epidemiológicos **Última atualização:** Abril de 2026

Estrutura Geral dos Conectores



Conceito Central: O que é Ludopatia

Ludopatia é um transtorno de saúde mental reconhecido pela OMS desde 1980 e pela CID-11 e DSM-5 como Transtorno do Jogo (código CID-10: F63.0). É caracterizada pela perda de controle sobre o comportamento de apostar, mesmo diante de prejuízos financeiros, emocionais e sociais contínuos. O termo vem do latim: *ludus* (jogo) + *pathos* (sofrimento/doença).

Dados epidemiológicos gerais (Brasil):

- Estimativa de **2,78 a 3 milhões** de brasileiros com ludopatia (Senado Federal / USP)
- Estimativa de **11 milhões** com tendência a desenvolver o transtorno
- É o **terceiro vício mais frequente** no Brasil, atrás apenas do álcool e tabagismo
- Atendimentos relacionados ao vício: 65 (2020) → 413 (2021) → 841 (2022) → 1.290 (2023) → 1.161 até nov/2024
- A ABP (Associação Brasileira de Psiquiatria) registrou crescimento de **mais de 300%** nos atendimentos em cinco anos

CONECTOR 1 — Ludopatia → Cultura

Hipótese central

O costume cultural brasileiro de apostar (loteria, Mega da Virada, jogo do bicho, bolões) criou historicamente um ambiente de normalização do jogo que predispõe ao desenvolvimento da ludopatia e facilita a adesão às BETs. A normalização cultural reduz a percepção de risco e abaixa a guarda da população diante de mecanismos mais agressivos de vício.

1. A normalização histórica pelo Estado: a loteria como porta de entrada

O Brasil tem uma relação institucionalizada com o jogo de azar operada pelo próprio Estado. As loterias federais da Caixa Econômica Federal (Mega-Sena, Quina, Lotofácil, Dupla Sena) fazem parte do cotidiano há décadas. Isso cria um fenômeno sociológico central: apostar é ensinado como algo normal, seguro e até patriótico — parte da arrecadação é repassada à saúde, segurança pública e cultura.

A normalização cultural do jogo reduz a percepção de risco, favorecendo a prática contínua sem reflexão sobre limites.

A Mega da Virada como ritual coletivo: Na edição de 2025, foram registradas **112 milhões de apostas**, com mais de 30 milhões apenas no último dia do ano. O volume foi tão alto que a Caixa adiou o sorteio da noite de 31 de dezembro para a manhã de 1º de janeiro de 2026. O bolão — aposta coletiva entre amigos, famílias e colegas — reforça o caráter social e festivo da prática, comparável ao próprio réveillon.

Ponto analítico: quando o Estado legitima e opera jogos de azar, envia a mensagem cultural de que apostar é inofensivo. Isso cria uma base comportamental que as BETs exploram com muito mais intensidade e sem as restrições simbólicas da loteria estatal.

2. Da loteria às BETs: a escalada da exposição

As BETs aprofundaram a normalização usando o futebol como veículo principal. As casas de apostas patrocinam os **20 clubes da primeira divisão** do futebol brasileiro e estão presentes em **70% das placas publicitárias** dos estádios. Um torcedor que assiste ao Brasileirão é exposto à publicidade de apostas durante 90 minutos em contexto emocional de alta intensidade.

A exposição massiva durante transmissões esportivas pode normalizar o ato de apostar, especialmente entre jovens. A combinação de emoção esportiva e estímulo financeiro cria um ambiente persuasivo. As casas de apostas investiram mais de **R\$ 550 milhões** em patrocínios à Série A em 2024.

3. O paradoxo da legitimidade

Um ponto analítico central é a **transferência de legitimidade**: a população associa as BETs às loterias da Caixa porque ambas são "apostas". Como a loteria nunca foi estigmatizada culturalmente, as BETs herdaram essa normalidade percebida.

O Instituto Locomotiva calculou que **25 milhões de pessoas** passaram a fazer apostas esportivas em plataformas eletrônicas nos primeiros sete meses de 2024. Em cinco anos, o número chegou a **52 milhões de brasileiros**.

4. Dados de mercado

- Mercado de apostas online cresceu **89% entre 2020 e 2024** (PwC)
- Brasil é o **terceiro maior mercado** mundial de apostas online
- BETs movimentam cerca de **R\$ 120 bilhões por ano** no Brasil
- **63% dos brasileiros** que apostam tiveram parte da renda comprometida com as BETs (SBVC/AGP Pesquisas)
- Beneficiários do **Bolsa Família** gastaram **R\$ 3 bilhões** em BETs via Pix em agosto de 2024 — equivalente a **R\$ 1 de cada R\$ 5 recebidos** (Banco Central / Câmara dos Deputados)

5. A resposta regulatória como evidência do problema

O Senado aprovou em maio de 2025 o PL nº 2.985/2023, com novo marco regulatório para publicidade de apostas:

- Faixas horárias restritas para anúncios (TV/streaming: apenas das 19h30 à meia-noite)
- Proibição de atletas, artistas e influenciadores em campanhas
- Proibição de marcas de apostas em uniformes de atletas menores de 18 anos
- Vedação de publicidade em estádios fora de contexto de patrocínio oficial

Essa legislação reconhece, implicitamente, que a cultura publicitária em torno das apostas havia atingido nível de saturação socialmente prejudicial.

Síntese analítica – Conector Cultura

Camada cultural	Mecanismo	Efeito na ludopatia
Loteria estatal (Caixa)	Legitimação governamental	Redução da percepção de risco
Mega da Virada	Ritualização coletiva anual	Naturalização social da aposta

Camada cultural	Mecanismo	Efeito na ludopatia
Patrocínio no futebol	Associação afetiva ao esporte	Exposição massiva e acrítica
Publicidade com influenciadores	Identificação e aspiração	Público jovem como alvo
BETs no celular 24h	Acesso irrestrito e imediato	Conversão do hábito cultural em vício

Palavras-chave – Conector Cultura

Português	Inglês
"ludopatia" "loteria" Brasil	"gambling disorder" "lottery" Brazil
"apostas" "normalização cultural"	"gambling normalization" culture
"jogo patológico" "cultura brasileira"	"pathological gambling" "cultural factors"
"Mega da Virada" comportamento	"national lottery" gambling behavior
"publicidade apostas" Brasil	"gambling advertising" Brazil

CONECTOR 2 — Ludopatia → Desestruturação Familiar

Hipótese central

O vício em apostas provoca perda progressiva de patrimônio (imóvel, móveis, poupança), ruptura conjugal, negligência com filhos e isolamento social, desestruturando o núcleo familiar de forma frequentemente irreversível. A desestruturação ocorre em camadas progressivas: primeiro financeira, depois relacional, depois afetiva — e afeta não apenas o apostador, mas todos ao seu redor.

1. O ciclo de perda financeira: "perseguição das perdas"

O mecanismo central da destruição patrimonial é clinicamente denominado *chasing losses* (perseguição das perdas): a plataforma ilude a pessoa a apostar mais, fazendo-a crer que quanto mais perde, mais deve investir para recuperar o prejuízo.

Dados de endividamento documentados:

- **86% das pessoas que apostam estão endividadas e 64% estão negativadas no Serasa** (Instituto Locomotiva, 2024)
- Mais de **60% dos jogadores compulsivos brasileiros** possuem dívidas superiores à renda mensal (IPq-USP, 2018)
- Relatos clínicos documentam perdas de poupanças de R\$ 380 mil, R\$ 450 mil, R\$ 780 mil e até R\$ 1,5 milhão
- Pais e mães de família que tinham casa quitada foram ao banco **refinanciar o imóvel** para obter dinheiro para jogar
- Estudo da PwC (2024) revelou que parte do orçamento familiar destinado a investimentos e despesas básicas está sendo redirecionado para apostas
- Brasileiros obtiveram R\$ 44,3 bilhões em prêmios, mas perderam R\$ 23,9 bilhões com apostas online entre junho de 2023 e junho de 2024 (Banco Itaú)

Ponto analítico: o saldo médio é sempre negativo, pois as plataformas são estruturalmente projetadas para reter mais do que pagam.

2. O impacto nas relações conjugais e familiares

O apostador compulsivo, ao esconder o comportamento da família, cria uma dupla crise: a financeira e a de confiança. Quando o problema é descoberto, o grau de endividamento já é severo.

Manifestações documentadas:

- Mentiras sistemáticas sobre o quanto aposta e os valores envolvidos
- Ocultação de comprovantes de aposta, extratos bancários e empréstimos
- Discussões frequentes sobre administração do dinheiro
- Venda de bens pessoais e da família sem consentimento
- Uso de cartão de crédito, cheque especial e empréstimos para financiar o vício

A compulsão por apostas afeta diretamente a saúde mental, com altos índices de estresse, ansiedade, depressão e risco aumentado de suicídio. A pessoa se isola, tem conflitos familiares e sociais, e quando a família descobre, geralmente já está endividada e falida.

Impacto nas relações conjugais: relatos clínicos e depoimentos na CPI das BETs documentam separações e divórcios diretamente relacionados ao vício em apostas. O isolamento social que acompanha o agravamento do transtorno — a pessoa deixa de frequentar eventos sociais, restaurantes, compromissos familiares — acelera a ruptura dos laços afetivos.

3. O impacto sobre crianças e adolescentes

Os jogos de azar representam risco às crianças e adolescentes, podendo levar a problemas de dependência e impactando negativamente seu desenvolvimento físico, emocional e social, além de aumentar a propensão para diversos tipos de vícios. O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) estabelece que é dever dos pais prover condições necessárias para uma vida digna e saudável aos filhos — obrigação comprometida quando a renda familiar é consumida pelo vício.

Impactos documentados sobre filhos:

- Comprometimento do acesso à educação (recursos desviados para apostas)
 - Exposição a contexto de conflito doméstico e instabilidade emocional
 - Risco de negligência parental
 - Exposição precoce à normalização do jogo, aumentando predisposição futura
-

4. A dimensão jurídica: direito de família e responsabilidade das BETs

O Instituto Brasileiro de Direito de Família (IBDFAM) publicou análise identificando que as apostas esportivas tornaram-se um fator de desagregação familiar, onde o orçamento doméstico destinado à educação, alimentação e poupança é consumido pelo vício.

Desafios jurídicos documentados:

- Ações de divórcio com alegação de dilapidação do patrimônio familiar por apostas
- Questões de guarda quando o genitor apostador compromete o bem-estar dos filhos
- Ações coletivas contra BETs por danos aos consumidores (fundamento: hipossuficiência e vulnerabilidade do CDC)
- Debate sobre responsabilidade civil objetiva das plataformas

A Lei 14.790/2023 gerou debate jurídico central: as casas de apostas podem ser responsabilizadas por comportamentos compulsivos dos jogadores? Já existem várias ações coletivas ajuizadas no TJSP e em outros tribunais.

5. Impacto macroeconômico e social

O comprometimento da renda familiar pelas BETs vai além do núcleo doméstico, afetando a economia local e os programas sociais:

- Os brasileiros já gastaram cerca de **R\$ 68 bilhões** em jogos virtuais (Banco Itaú)
- Estima-se que **0,22% do PIB** foi destinado a apostas online nos últimos 12 meses

- **5 milhões de beneficiários do Bolsa Família** gastaram **R\$ 3 bilhões** com apostas via Pix em agosto de 2024 — equivalente a **R\$ 1 de cada R\$ 5** pagos pelo governo (Banco Central)
- As BETs competem com consumo de educação, saúde e lazer, comprimindo a renda disponível das famílias de menor renda
- As apostas esportivas comprometem desproporcionalmente o orçamento das classes D e E (PwC, 2024)

Síntese analítica - Conector Desestruturação Familiar

Fase	Manifestação	Impacto familiar
Início	Apostas escondidas, pequenas perdas	Mentira, segredo, distanciamento
Escalada	Endividamento crescente	Conflitos, tensão financeira
Crise	Venda de bens, refinanciamento de imóvel	Ruptura conjugal, negligência com filhos
Colapso	Insolvência total, isolamento social	Dissolução do núcleo familiar
Sequela	Crianças expostas a ambiente de risco	Impacto geracional

Palavras-chave - Conector Desestruturação Familiar

Português	Inglês
"ludopatia" "família" impacto	"gambling disorder" "family impact"
"jogo patológico" divórcio	"pathological gambling" divorce
"vício em apostas" endividamento	"gambling addiction" debt
"BETs" "impacto familiar"	"sports betting" family consequences
"jogo compulsivo" "violência doméstica"	"compulsive gambling" domestic violence
"apostas" "superendividamento" família	"gambling" "over-indebtedness" family

CONECTOR 3 — Ludopatia → Desenvolvimento (Epidemiológico)

Hipótese central

A popularização das BETs potencializa o desenvolvimento da ludopatia, especialmente em

pessoas com ansiedade e depressão. O transtorno não se desenvolve aleatoriamente: há perfis de vulnerabilidade identificáveis, e as BETs exploram características neurológicas e psicológicas específicas para capturar e reter usuários. O quadro configura uma emergência de saúde pública.

1. O mecanismo neurológico: dopamina e o sistema de recompensa

A dinâmica do vício em jogos é semelhante à dependência de substâncias químicas. As plataformas utilizam mecanismos que estimulam a repetição compulsiva, ativando o sistema de recompensa do cérebro de forma semelhante às drogas. Quando uma pessoa aposta, o cérebro libera **dopamina** — neurotransmissor do prazer. Com o tempo, a necessidade de repetir o estímulo cresce, e são necessárias apostas progressivamente maiores para obter a mesma sensação — mecanismo idêntico à tolerância em dependências químicas.

Evidências clínicas associam o jogo patológico a **alterações cerebrais em áreas relacionadas à tomada de decisão, controle inibitório e reforço dopaminérgico** (Teixeira et al., Brazilian Journal of Health Review, 2025). O psiquiatra Hermano Tavares, que coordena o Ambulatório do Jogo Patológico do Hospital das Clínicas da USP, sintetizou: "É como se tivéssemos instalado um cassino em cada bolso."

2. Comorbidades: ansiedade e depressão como fatores de risco e consequência

A relação entre ludopatia e saúde mental é bidirecional: transtornos prévios aumentam o risco de desenvolver o vício, e o vício agrava os transtornos existentes.

Dados de comorbidade documentados:

- **51% dos brasileiros que apostam** sentem aumento de sintomas ansiosos (Instituto Locomotiva)
- **42%** usam as apostas como fuga ilusória das dificuldades cotidianas, mas o vício aprofunda o sofrimento em vez de aliviá-lo (Instituto Locomotiva)
- Especialistas documentam aumento expressivo na demanda por atendimento de pessoas com sintomas de ansiedade, depressão, crises de pânico e ideação suicida associada ao uso compulsivo das plataformas (Altay de Souza, doutor em Psicologia Experimental, USP / Radis Fiocruz, 2025)
- Entre dependentes, o consumo de álcool e nicotina pode **dobrar**, agravando o quadro clínico e emocional (PRO-AMJO/USP)

Mecanismo da fuga: jovens com menor supervisão parental e aqueles que enfrentam dificuldades emocionais como depressão e ansiedade são mais propensos a desenvolver comportamentos compulsivos em relação ao jogo (Journal of Gambling Studies, 2024).

3. O dado mais grave: ideação suicida

Este é o dado mais crítico do conector Desenvolvimento e deve ser tratado com destaque no artigo.

Cerca de 80% das pessoas que procuram tratamento no PRO-AMJO (Programa Ambulatorial do Jogo do Instituto de Psiquiatria do HC-FMUSP/USP) apresentam **ideação suicida** (dados institucionais do IPq-HCFMUSP, 2025).

O psicólogo Edilson Braga, do PRO-AMJO, explicou: "As pessoas que desenvolveram o transtorno demoram, em média, **oito anos** para procurar ajuda. Quando chegam aqui, provavelmente já perderam tudo. Chegam sem ver luz no fim do túnel, já querendo tirar a própria vida."

Outros dados sobre suicídio:

- Estudo do IPq-USP (2018) revelou que **27% dos jogadores compulsivos brasileiros** apresentaram ideação suicida, especialmente entre jovens de 18 a 29 anos
 - No estado de São Paulo, **quatro suicídios** foram registrados com relação direta às apostas em 2024; no Maranhão, **três** (PUC Minas / Polícia Civil)
 - Um caso documentado pela FAPESP relata um homem de 28 anos que tentou suicídio após endividar-se com apostas esportivas online (Foppa et al., Brazilian Journal of Psychiatry, 2024)
 - Revisão sistemática da Revista de Geopolítica (2026) confirma apostas online como **fator de risco emergente** para comportamento suicida em populações vulneráveis
-

4. Perfis de vulnerabilidade identificados

Pesquisas brasileiras identificam grupos com maior risco de desenvolvimento da ludopatia:

Homens jovens (18-29 anos): "Quando analisamos a população com maior risco de desenvolver vício em jogos, geralmente são homens jovens solteiros, ou casados por menos de cinco anos, com dificuldades financeiras" (Caio Parada Cabral, doutor em psicologia do desenvolvimento / Brasil de Fato, 2024).

- **18,6% dos meninos e 6,1% das meninas** entre 13 e 19 anos já se envolveram em algum tipo de aposta (Journal of Gambling Studies, 2024)
- Jovens de 18 a 24 anos são os **mais expostos** ao vício em apostas online, motivados principalmente pela busca de ganhos rápidos (ANBIMA, 2025)
- **54% dos jovens apostadores** indicam o desejo de ganhar dinheiro rápido como principal motivação (Instituto Locomotiva)
- Universitários relatam queda no rendimento escolar, evasão e endividamento irreversível

Pessoas com histórico de saúde mental: Condições como depressão, vícios em outras substâncias e histórico familiar de vício em jogos aumentam significativamente a predisposição (Caio Parada Cabral, 2024).

Classes D e E: O tipo de jogo acessível por celular tem seu nicho de exploração entre os mais pobres, pela facilidade de acesso. O apostador das classes mais desfavorecidas tende a encarar a aposta como investimento, o que, associado ao comportamento compulsivo, torna-se a fórmula perfeita para o vício (Prof. Marcelo Pereira de Mello, UFF).

Adolescentes: O número de adolescentes expostos aumentou muito desde a legalização dos jogos online. "Embora ainda seja proibido apostar antes dos 18 anos, isso é amplamente desrespeitado. O impacto nessa faixa etária é particularmente cruel: compromete a formação escolar, a saúde mental e a inserção social" (Hermano Tavares, USP / Radis Fiocruz, 2025).

5. A subnotificação como problema metodológico central

A ludopatia tem caráter silencioso e subnotificado. Os apostadores compulsivos escondem o comportamento da família e da rede social por vergonha e por não reconhecerem a dependência como doença. Isso atrasa o diagnóstico em média **8 anos** (PRO-AMJO/USP).

Causas estruturais da subnotificação:

- Ausência de campanhas públicas de conscientização
- Falta de mecanismos de rastreio na atenção primária
- Formação insuficiente de profissionais de saúde para identificar o transtorno
- Inexistência de protocolos clínicos nacionais específicos para ludopatia no SUS
- CAPS podem receber pessoas com jogo patológico, mas a atuação é incipiente e depende da percepção das equipes locais

Dado alarmante: aproximadamente **um terço** dos entrevistados em estudos brasileiros com amostras de apostadores preenche critérios para ludopatia — muito acima das estimativas oficiais de 1% a 1,5% da população.

6. Curva epidemiológica e as BETs como catalisador

Ano	Atendimentos SUS por ludopatia	Variação
2018	108	—
2020	65*	*queda pandemia
2021	413	+535%

Ano	Atendimentos SUS por ludopatia	Variação
2022	841	+104%
2023	1.290	+53%
2024 (até nov.)	1.161	—

Fonte: Câmara dos Deputados (PL 4583/24) / Migalhas (2025)

A curva é diretamente paralela à expansão das BETs após a Lei 13.756/2018, com pico de crescimento entre 2020 e 2021 (disseminação das plataformas digitais durante a pandemia). Apenas **1% do total arrecadado pelas BETs** é destinado a medidas de prevenção, controle e mitigação de danos sociais (Lei 14.790/2023).

7. Tratamento disponível e lacunas

Opções de tratamento:

- **TCC (Terapia Cognitivo-Comportamental):** primeira linha; foco na reestruturação de pensamentos distorcidos (ilusão de controle, negação das perdas, esperança de recuperação financeira). A participação da família é essencial
- **PRO-AMJO (USP):** Programa Ambulatorial do Jogo do HC-FMUSP; referência nacional
- **Jogadores Anônimos (JA):** no Brasil desde os anos 1990, modelo dos 12 passos
- **CAPS:** referência no SUS, sem protocolos específicos para ludopatia
- **Plataforma Centralizada de Autoexclusão:** bloqueia acesso a todas as casas de apostas licenciadas de uma só vez
- **Medicação:** indicada em casos de comorbidades (ansiedade, depressão, transtorno bipolar)

Lacunas críticas:

- Sem campanha nacional de prevenção específica para ludopatia
- Sem protocolo clínico nacional no SUS
- Fila de espera crescente no PRO-AMJO
- Apenas 1% da arrecadação das BETs destinado à saúde

Projeto legislativo: O PL 4583/24 (Câmara dos Deputados) propõe criar o Programa Nacional de Assistência Integral às Pessoas com Transtorno de Jogo, utilizando as estruturas do SUS, SUAS e RAPS.

Síntese analítica - Conector Desenvolvimento

Fator	Mecanismo	Consequência
Dopamina / neurológico	Sistema de recompensa sequestrado	Compulsão crescente, tolerância
Ansiedade / depressão	Aposta como regulação emocional	Comorbidade e piora dos quadros
Vulnerabilidade econômica	Promessa de renda fácil	Endividamento progressivo
Acesso digital 24h	BETs no celular a qualquer hora	Exposição irrestrita, recaídas
Subnotificação	Ausência de diagnóstico precoce	Agravamento antes da busca por ajuda
Ideação suicida	Colapso total sem saída percebida	Risco de vida; 80% dos pacientes do PRO-AMJO

Palavras-chave - Conector Desenvolvimento

Português	Inglês
"ludopatia" prevalência Brasil	"gambling disorder" prevalence Brazil
"jogo patológico" "ansiedade" "depressão"	"pathological gambling" anxiety depression
"BETs" "saúde mental" Brasil	"sports betting" "mental health" Brazil
"apostas online" ideação suicida	"online gambling" suicidal ideation
"ludopatia" epidemiologia	"gambling disorder" epidemiology
"transtorno do jogo" comorbidade	"gambling disorder" comorbidity
"jogo patológico" dopamina neurobiologia	"pathological gambling" dopamine neurobiology

Referências Bibliográficas Identificadas na Pesquisa

Artigos científicos

- TEIXEIRA, J. M. et al. *Ludopatia entre a promessa do lucro e o colapso psíquico: jogos de*

azar digitais, vício dopaminérgico e seus danos além da saúde mental. Brazilian Journal of Health Review, v. 8, n. 3, 2025. DOI: 10.34119/bjhrv8n3-316

- FOPPA, G. T. et al. *Online sports betting as an expression of antisocial behavior*. Brazilian Journal of Psychiatry, fev. 2024
- KRISTENSEN, J. H. et al. *Suicidality among individuals with gambling problems: A meta-analytic literature review*. Psychological Bulletin, jan. 2024
- BAKER, S. R. et al. *Gambling away stability: Sports betting's impact on vulnerable households*. SSRN, jul. 2024
- TRAN, L. T. et al. *The prevalence of gambling and problematic gambling: A systematic review and meta-analysis*. The Lancet Public Health, ago. 2024
- TAVARES, H. et al. *Gambling in Brazil: Lifetime prevalences and socio-demographic correlates*. Psychiatry Research, nov. 2010
- POTENZA, M. et al. *Gambling disorder*. Nature Reviews - Disease Primers, jul. 2019
- UKHOVA, D. et al. *The expansion of gambling across the Americas poses risks to mental health and wellbeing*. Lancet Regional Health Americas, 2024
- SOUZA et al. (2020) — estudos sobre jogo patológico no Brasil
- BASTOS (2022) — regulação de jogos digitais no Brasil
- WEBER, C. A. T.; DA SILVA, A. G. *Mentes apostadoras: o que há atrás das BETS?* Debates em Psiquiatria, 2025

Referências clínicas e institucionais

- DSM-5 (APA, 2013) — Transtorno do Jogo
- CID-11 (OMS, 2018) — Transtornos relacionados ao jogo
- IPq-USP (2018) — dados sobre jogadores compulsivos brasileiros
- PRO-AMJO / HC-FMUSP/USP — dados de atendimento e ideação suicida
- GRANT, J. E. et al. *Pathological gambling: a clinical guide to treatment*. APA Publishing, 2010
- LESIEUR, H. R.; BLUME, S. B. *The South Oaks Gambling Screen (SOGS)*. American Journal of Psychiatry, 1987

Fontes de dados brasileiros

- Instituto Locomotiva — pesquisas sobre comportamento de apostadores (2024)
- Associação Brasileira de Psiquiatria (ABP) — dados de atendimento
- PwC — mercado de apostas online no Brasil (2024)
- Banco Central do Brasil — gastos com BETs via Pix
- Banco Itaú — gastos e perdas com apostas online

- ANBIMA — pesquisa sobre apostas online e saúde mental (2025)
- CPI das BETs — Senado Federal (2024)
- IBDFAM — impactos no Direito de Família (2024)

Referências Legislativas e Regulatórias

Documento	Conteúdo
Decreto-Lei nº 9.215/1946	Proibição histórica dos jogos de azar no Brasil
Lei nº 13.756/2018	Autorização das apostas de quota fixa (BETs)
Lei nº 14.790/2023	Regulamentação do mercado de BETs
Portaria MF nº 1.330/2023	Regras operacionais para casas de apostas
Portaria SPA nº 1.231/2024	Restrições de publicidade de apostas
PL nº 2.985/2023 (Senado, mai/2025)	Marco regulatório de publicidade de BETs
PL nº 4.583/2024 (Câmara)	Programa Nacional de Assistência à Ludopatia
Portaria MS nº 3.088/2011	Rede de Atenção Psicossocial (RAPS)

Bases de Dados para Pesquisa

- **Google Acadêmico** — cobertura ampla em português
- **PubMed / MEDLINE** — artigos clínicos internacionais
- **SciELO** — produção científica brasileira e latino-americana
- **PsycINFO** — psicologia e saúde mental
- **LILACS** — literatura latino-americana em saúde
- **IBGE / IPEA** — dados socioeconômicos brasileiros
- **Revista Pesquisa FAPESP** — produção científica brasileira
- **Brazilian Journal of Health Review** — artigos recentes sobre o tema

Próximos Passos da Pesquisa

1. Realizar buscas sistemáticas nas bases com os termos organizados por conector

2. Priorizar artigos de 2018-2025 (período pós-legalização das BETs)
3. Mapear autores recorrentes → buscar outras obras dos mesmos pesquisadores (destaque: Hermano Tavares, USP; Potenza, Yale; Altay de Souza, USP)
4. Cruzar dados epidemiológicos do Ministério da Saúde com a curva de expansão das BETs
5. Buscar jurisprudência sobre ações contra BETs no TJSP e STJ
6. Analisar os relatórios da CPI das BETs (Senado, 2024) como fonte documental primária
7. Acessar o relatório da ANBIMA (maio de 2025) sobre apostas online e saúde mental
8. Buscar o artigo de Foppa et al. (Brazilian Journal of Psychiatry, 2024) na íntegra
9. Consultar o Ambulatório PRO-AMJO/USP para dados atualizados de atendimento
10. Verificar o PL 4583/24 no site da Câmara dos Deputados para acompanhamento de tramitação